



Selektiver Mutismus in der Arztpraxis

Ein Leitfaden

Liebe Leserschaft,

mein Name ist Pia Zucht und ich bin Mutismus-Therapeutin in Berlin. Seit Jahren erlebe ich, wie belastend Arztbesuche für Betroffene sein können, während Ärztinnen und Ärzte oft Unsicherheit im Umgang mit diesem Störungsbild beschreiben. Aus diesem Grund entstand die Idee für diesen praxisnahen Leitfaden.

In enger Zusammenarbeit mit der Mutismus Selbsthilfe Deutschland e. V., der Universität Erfurt sowie Expert*innen aus Pädiatrie, Allgemein- und Zahnmedizin, konnten wir Bedarfsanalysen durchführen und wertvolle Perspektiven von Betroffenen, Angehörigen und Therapeut*innen einfließen lassen.

Unser Ziel ist es, mit der hier vorliegenden Broschüre Ärztinnen und Ärzten hilfreiche Werkzeuge an die Hand zu geben, um die durch selektiven Mutismus entstehenden Barrieren zu überwinden (für Betroffene gibt es einen entsprechenden Wegweiser auf der Website mutismus.de). Diese Broschüre bietet sowohl den theoretischen Hintergrund als auch praktische Tipps und Anregungen, um den Umgang mit Betroffenen in Ihrer Praxis zu erleichtern.

Ein besonderer Dank gilt den Betroffenen und ihren Familien, deren Offenheit und Erfahrungen maßgeblich zur Erstellung dieses Leitfadens beigetragen haben. Ebenso möchte ich mich herzlich bei Manja Mintel und Dr. Amelie Abarca für ihre unermüdliche Unterstützung bedanken.

Wir laden Sie herzlich ein, die in diesem Leitfaden vorgestellten Ansätze auszuprobieren und Ihre Erfahrungen zu teilen. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie am Ende der Broschüre. Durch einen offenen Austausch können wir gemeinsam die medizinische Betreuung von Menschen mit selektivem Mutismus verbessern.

Herzlichst,

Pia Zucht

Inhaltsverzeichnis

Definition.....	4
Diagnosekriterien nach DSM-5.....	5
Formen von Mutismus.....	6
Prävalenz.....	6
Ätiologie.....	6
Weitere Risikofaktoren.....	7
Erscheinungsbild und Leitsymptomatik.....	8
Gehäuft beobachtbare Komorbiditäten	10
Ausschluss- und Differentialdiagnosen	11
Differentialdiagnose Autismus-Spektrum-Störung	12
Abgrenzung Schüchternheit.....	14
Hochsensibilität und Mutismus.....	15
Diagnosestellung.....	16
Therapie.....	18
Prognose.....	19
Flussdiagramm - „Ein schweigendes Kind kommt in die Praxis“	20
Praktische Tipps für den Umgang in der Arztpraxis	22
Hilfsmittel.....	26
Umgang mit Jugendlichen und Erwachsenen.....	28
Betroffene auf den Arztbesuch vorbereiten.....	29
Die Geschichte von Alwa, die das Hüpfen lernte	30
Informationen und Links.....	32
Literaturverzeichnis.....	34

„Schweigen ist der sicherste Weg für den,
der seiner selbst unsicher ist.“

François de La Rochefoucauld

DEFINITION

„Selektiver Mutismus ist durch eine deutliche, emotional bedingte Selektivität des Sprechens charakterisiert, so dass das Kind in einigen Situationen spricht, in anderen definierbaren Situationen jedoch nicht.“

(DILLING & FREYBERGER, 2019)

Diagnosekriterien nach DSM-5

- A** Andauernde Unfähigkeit, in bestimmten Situationen zu sprechen, wobei in anderen Situationen wiederum normale Sprechfähigkeit besteht.
- B** Die Störung behindert die schulischen oder beruflichen Leistungen oder die soziale Kommunikation.
- C** Die Störung dauert mindestens einen Monat (und ist nicht auf den ersten Monat nach der Einschulung beschränkt).
- D** Die Unfähigkeit zu sprechen ist nicht durch fehlende Kenntnisse der gesprochenen Sprache bedingt oder dadurch, dass der Betroffene sich in dieser Sprache nicht wohl fühlt.
- E** Das Störungsbild kann nicht besser durch eine Kommunikationsstörung (z. B. Redeflussstörung mit Beginn in der Kindheit) erläutert werden und tritt nicht ausschließlich im Rahmen einer Autismus-Spektrum-Störung, einer Schizophrenie oder einer anderen psychotischen Störung auf.

Zugehörige Merkmale:

- Schüchternheit
- Angst vor Befangenheit in sozialen Situationen
- Soziale Isolierung und sozialer Rückzug
- Anhänglichkeit
- Zwanghafte Verhaltensweisen
- Negativismus
- Wutanfälle oder leicht oppositionelle Verhaltensweisen



ICD-Codes

ICD-10: F94.0

Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend – Elektiver Mutismus (inkl. Selektiver Mutismus)

ICD-11: 6B06

Angst- oder furchtbezogene Störungen – selektiver Mutismus

Formen von Mutismus

- **Selektiver Mutismus**, auch **elektiver Mutismus** genannt: Es kann situations- und personenabhängig gesprochen werden.
- **Totaler Mutismus**: Nach abgeschlossenem Spracherwerb wird gar nicht mehr gesprochen, obwohl keine medizinische Ursache vorliegt.
- **Akinetischer Mutismus**: Diese Form des Mutismus tritt im Rahmen einer schweren psychischen oder neurologischen Störung auf.

Prävalenz

Selektiver Mutismus ist eine Kommunikationsstörung, die bei 2 bis 8 von 10.000 Kindern auftritt (Steinhausen et al., 2006). Die Störung tritt mit einer Prävalenz von 0,03 bis 1 % auf, wobei Mädchen etwas häufiger betroffen sind als Jungen. Die Dunkelziffer ist jedoch sehr hoch, da selektiver Mutismus vielfach unbekannt ist und häufig als Schüchternheit, oppositionelles Verhalten oder anderes fehlinterpretiert wird.

(Rogoll & Ströhle, 2021)

Ätiologie

Jedes Schweigen erfüllt eine Funktion, hat einen Sinn. Da die Bedeutung des Schweigens höchst individuell ist, können nicht alle Ursachen aufgeführt werden. Es folgt ein orientierender Überblick.

Die aktuelle Forschung betrachtet selektiven Mutismus als eine unwillkürliche Stressreaktion durch subjektiv erlebte Unsicherheit. (Melfsen et al., 2021; Florineth-Baatsch et al. 2024; Zucht, 2024)

Auch wenn Mutismus als Folge von Trauma, Milieuschäden und Deprivation auftreten kann, wird dieser Aspekt in der ICD-11 nicht mehr erwähnt. Als organische Ursachen gelten:

- **Genetik**: Risikofaktoren wie Gehemmtheit, Angst oder Depression treten familiär gehäuft auf.
- **Hyperfunktion der Amygdala**: Das Angstzentrum im limbischen System befindet sich in permanenter Alarmbereitschaft.
- **Neurobiologie**: Es kommt zu Dysbalancen der Neurotransmitter im Hirnstoffwechsel.

(Hartmann & Lange, 2024)

Weitere Risikofaktoren

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

- Migration (28 %) und Bilingualität (22 %), ggf. kulturelle Diskrepanzen und mangelnder Assimilationsprozess der immigrierten Familie
- Psychische Störungen und Persönlichkeitsstörungen der Eltern (10,5 %)
- Mutistisch anmutende Verhaltensweisen der engsten Angehörigen (72,2 %)
- Isolation und Schüchternheit der Eltern
- Prä-, peri- und postnatale Komplikationen (75 %)
- Kritische Lebensereignisse / Trauma
- Bindungs- und Entwicklungstrauma (komplexe Posttraumatische Belastungsstörung)
- Schweigen als Zeichen der Loyalität
- Schweigen als dysfunktionale Bindungsstrategie
- Körperliche Beeinträchtigungen / Erkrankungen
- Geschwister- oder Zwillingskonstellation
- Allgemeine elterliche Strenge
- Sprach- und Sprechstörungen, wie beispielsweise Stottern, Artikulations- und Sprachentwicklungsstörungen

(Florineth-Baatsch et al., 2024)

Stein et al. konnten bereits 2011 ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung des selektiven Mutismus bei Vorliegen einer Abweichung des Gens CNTNAP2 auf Chromosom 7 nachweisen.



Um diese genetische Disposition und aufrechterhaltende Faktoren zu explorieren, empfiehlt sich der **Kölner Mutismus Anamnese-Bogen (K-M-A)**:

Erscheinungsbild und Leitsymptomatik

Bei selektivem Mutismus besteht eine ausgeprägte Körpersymptomatik aufgrund eines erhöhten Stresspegels. Die Intensität der Reaktion ist individuell verschieden. Häufig zu beobachten sind bei Ansprache durch bindungsferne Personen in unterschiedlichem Ausprägungsgrad:

Physisch

- ✓ Meiden des Blickkontakts
- ✓ Einfrieren/Schockstarre
- ✓ Verkrampfte Hände
- ✓ Blockierte/stockende Atmung
- ✓ Erhöhter bis sehr hoher Körpertonus
- ✓ Starre, ausdruckslose Mimik
- ✓ Verstecken hinter Masken, Haaren, Kleidung
- ✓ Klein- und Unsichtbarmachen (Kinder verstecken sich teilweise hinter Eltern oder Gegenständen)
- ✓ Miktion/Defäkation, Nahrungsaufnahme und Trinken sind in der Öffentlichkeit ggf. nicht umsetzbar

Zusätzliche Symptome

- ✓ Das Kind zeigt teils autoritäres Verhalten und redet übermäßig viel (Nachholbedarf).
- ✓ Das Kind hat Schwierigkeiten, Interaktionen zu initiieren (z. B. Begrüßung/Abschied/Dank/Fragen).
- ✓ Übergangssituationen (Wechsel von „vertraut“ zu „fremd“) stellen besondere Herausforderungen dar.
- ✓ In der Schule wird das Nicht-Sprechen oft mit guten schriftlichen Leistungen kompensiert, teils ist Perfektionismus beobachtbar.
- ✓ Das Kind scheint die es umgebende Welt im Vergleich zu den Altersgenossen sorgfältiger zu beobachten und wahrzunehmen (auch im Hinblick auf Stimmungen und Emotionen), es hat aber oft Schwierigkeiten, eigene Gefühle auszudrücken.
- ✓ Das Kind zeigt häufig keine/kaum Emotionen (es weint z. B. nicht, wenn es sich wehtut).
- ✓ Das Kind zeigt nonverbal verzögerte Reaktionen, es fällt ihm sehr schwer, Entscheidungen zu treffen.

(Katz-Bernstein, 2019)



Gehäuft beobachtbare Komorbiditäten

Nur sehr selten tritt selektiver Mutismus isoliert auf, fast immer bestehen Komorbiditäten. Zu beachten ist, was das klinische Bild dominiert. Nach Florineth-Baatsch et al. (2024) sind häufig Enuresis, Enkopresis, Schlafstörungen, soziale Ängstlichkeit, Essstörungen, depressive Symptome und Regulationsstörungen der Verhaltenskontrolle zu beobachten.

Weitere mögliche Auffälligkeiten

- Zwänge oder zwangsähnliches Verhalten
- Gesteigerte Sensibilität bis Hochsensibilität
- Auffälligkeiten im Bereich des Bindungsmusters
- Persistierende frühkindliche Reflexe



Ausschluss- und Differentialdiagnosen

Folgende Störungen sind vom selektiven Mutismus abzugrenzen, können jedoch komorbid auftreten:

- Passagerer (selektiver) Mutismus als Teil einer Trennungsangst bei jungen Kindern
- Hördefizite – damit verbunden Formen des partiellen oder totalen Schweigens
- Sprachentwicklungsstörungen
- Sprechangst
- Soziale Phobie
- Störungen der kognitiven Entwicklung
- Auditive Agnosie

(Florineth-Baatsch et al., 2024)

Differentialdiagnose Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

Mutismus und Autismus klingen ähnlich und weisen äußerlich Ähnlichkeiten auf, im Kern sind sie jedoch grundverschieden. Mutismus ist heilbar und neurotypisch, wohingegen ASS eine tiefgreifende Entwicklungsstörung beschreibt, bei der Neurodiversität vorliegt. Dennoch können die Symptome eine Diagnosestellung komplizieren, da das Fehlen von sozialer Interaktion, Blickkontakt, Mimik, Gestik, Sprache, die teils starke Reaktion auf sich verändernde Situationen, ggf. sensorische Empfindlichkeiten und das beeinträchtigte Spielverhalten mit Peers in beiden Störungsbildern vorkommen können. Der Ausprägungsgrad der einzelnen Symptome sowie der Übereinstimmung ist dabei individuell verschieden.

Daher folgt hier und auf S. 13 eine **Reihe von Fragen**, mit denen Sie in der anamnestischen Erhebung explorieren können, ob es sich um **ASS** oder **Mutismus** handelt. Wenn die Angehörigen die Frage mit „Ja“ beantworten können, ist es eher:

TYPISCH FÜR MUTISMUS

- ✓ Spricht das Kind zu Hause und nutzt es dabei Mimik und Gestik in unauffälliger Weise?
- ✓ Hat es im Kleinkindalter Blickkontakt hergestellt?
- ✓ Versteht es Metaphern (sprachliche Bilder und Redewendungen wie „Das Buch hat mich gefesselt.“)?
- ✓ Reziproke Kommunikation: Stellt Ihr Kind Ihnen auch Rückfragen?
- ✓ Kann Ihr Kind empathisch reagieren?
- ✓ Ist es möglich, einen alterstypischen Dialog zu führen?
- ✓ Spielverhalten zu Hause: Spielt Ihr Kind vielseitig und in Symbol- und Rollenspielen („so tun als ob“)?
- ✓ Unterscheidet sich das Spiel in der Kita oder Schule vom Spiel im heimischen Rahmen?

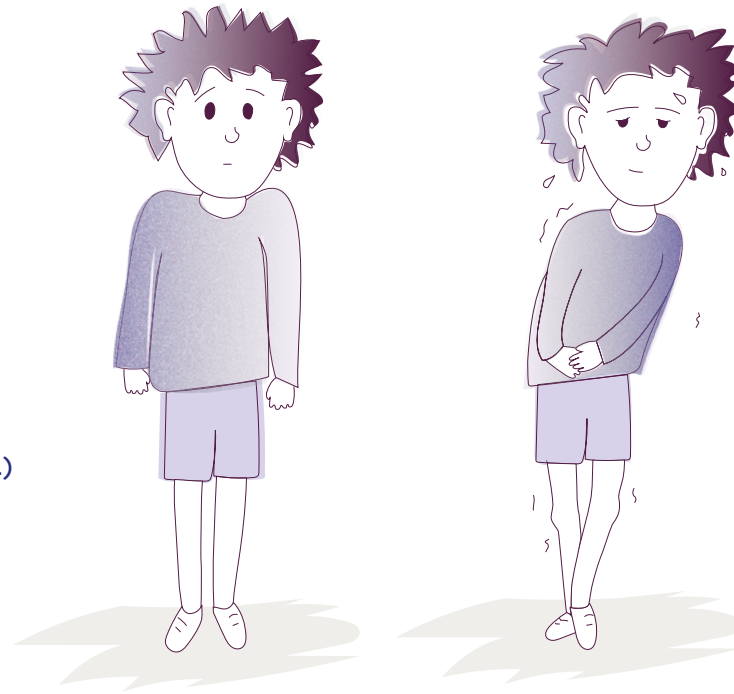
TYPISCH FÜR AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNG

- ✓ Ist das Kind von Metaphern irritiert?
- ✓ Reziproke Kommunikation: Spricht Ihr Kind ausschließlich von eigenen Erlebnissen, ohne Rückfragen zu stellen?
- ✓ Hat Ihr Kind Schwierigkeiten, Dialoge zu führen?
- ✓ Welches Spielverhalten beobachten Sie zu Hause? Handelt es sich um einseitiges Spielverhalten, das sich auf einzelne Interessen beschränkt? Zeigt es Stereotypien?
- ✓ Beobachten Sie Wahrnehmungsauffälligkeiten, wie z. B. Hypo- oder Hypersensibilität auf Licht, Geräusche, Berührungen, Geschmack und Textur?
- ✓ Zeigt Ihr Kind repetitive Verhaltensweisen oder bei extremer Überlastung das sog. Stimming („Self-stimulating behaviour“, selbst stimulierendes Verhalten), z. B. Hin-und-her-Schaukeln, Wippen, Fingerschnipsen, Summen oder lautes Zählen?
- ✓ Kommt Ihr Kind bei reizbedingter Überlastung zum Meltdown (emotionaler Zusammenbruch), der Weinen, Schreien, Schlagen, Autoaggression oder Erstarrung zur Folge haben kann? Einem Meltdown oder einer Reizüberflutung (Overload) folgt der völlige Rückzug, bei dem das Kind nicht mehr ansprechbar ist (Shutdown).
- ✓ Bestehen Auffälligkeiten in der Grobmotorik bei unauffälliger Feinmotorik?
- ✓ Sind die Interessen Ihres Kindes starr und fixiert auf einzelne Bereiche?
- ✓ Reizüberflutung: War Ihr Kind ein Schreikind? Dies kann ein Hinweis auf Neurodiversität sein.
- ✓ Wurde im Säuglingsalter schon festgestellt, dass Ihr Kind auf Reize übermäßig reagiert?

Abgrenzung Schüchternheit

Mutismus weist eine andere Konsequenz des Schweigens auf als **Schüchternheit**. Diese äußert sich durch sympathische Aktivierung und löst sich nach etwa 30 Minuten, sodass typentsprechend mehr oder weniger gesprochen werden kann. Mutismus bleibt bestehen, das Schweigen löst sich nicht ohne Weiteres auf, zudem besteht häufig die automatische Stress- und Schutzfunktion des Erstarrens, die auch Mimik und Gestik beeinträchtigt oder verhindert.

(von Frankenberg & Schröter, 2021)



Bei Verdacht auf Mutismus: Nutzen Sie beispielsweise die Screeningbögen der TU Dortmund (DortMuS-Eltern, -Schule, -Kita).

Hochsensibilität und Mutismus

Die aktuelle Forschung beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen selektivem Mutismus und erhöhter sensorischer Reizbarkeit. Bei Personen mit Mutismus ist die Amygdala inadäquat hoch aktiviert, daher ist es günstig, eine etwas ruhigere Atmosphäre zu schaffen, um einer Überstimulation vorzubeugen.

Praktische Tipps dazu finden Sie unter den Punkten „Zeit nehmen“ und „Positive Haltung“ (Kapitel „Umgang in der Arztpraxis“) auf S. 22 und 23.



Diagnosestellung

Selektiver Mutismus kann durch Fachpersonen aus der Pädiatrie, Allgemeinmedizin, Psychologie, Psychiatrie und von Heilpraktiker*innen für Psychotherapie diagnostiziert werden.

Therapeut*innen dürfen die Diagnose nicht stellen, es sei denn, sie verfügen über eine psychologische Ausbildung mit entsprechender Heilerlaubnis.

Es besteht die Möglichkeit, zur Sicherung der Diagnose, Therapeut*innen zurate zu ziehen, die auf selektiven Mutismus spezialisiert sind. So können Sie etwa 3 Stunden zur Abklärung verordnen und um einen ausführlichen Bericht bitten. Es ist für den

Therapiebeginn nicht nötig, dass eine psychiatrische Diagnostik durchgeführt oder das Kind im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) befundet wurde.

Um die Diagnose zu stellen, müssen alle Kriterien laut DSM-5 oder ICD-10 erfüllt sein. Bedenken Sie dabei bitte, dass der Ausprägungsgrad individuell verschieden sein kann. Wenn ein Kind NUR in der Arztpraxis konsequent schweigt, in anderen Situationen aber uneingeschränkt kommuniziert, ist der Leidensdruck entscheidend. Sollte dieser bestehen, ist Therapie indiziert.

Diagnoseschlüssel

SP 1 oder RE 1

ICD-10: F94.0

ICD-11: 6B06

weitere mögliche Diagnosen für Sprachtherapie:

ICD-10: F80.0 / 1/ 8 / 9

ICD-11: 6A01



Therapie

Empfohlen wird ein interdisziplinäres Vorgehen. Qualifizierte Mutismustherapie bei speziell dafür ausgebildeten therapeutischen Berufsgruppen mit entsprechender Weiterbildung ist indiziert. Sie finden unter „Informationen und Links“ (S. 32) aktuelle Therapeut*innen-Verzeichnisse. Ausgehend von der Listung der qualifizierten Fachkräfte (N=600) in Deutschland ist die prozentuale Verteilung der Fachdisziplinen wie folgt:

Logopädie/Sprachtherapie	88,7 %
Heilpädagogik	4,9 %
Psychotherapie	4,6 %
Musik-, Kunst- und Ergotherapie	1,8 %

(Bahrfeck & Kramer, 2024)

In Deutschland etablierte Therapieansätze

Dortmunder Mutismus-Therapie	(DortMuT)
Kooperative Mutismus-Therapie	(KoMut)
Systemische Mutismus-Therapie	(SYMUT)
Mutig sprechen	(PCIT-SM)

(von Frankenberg & Schröter, 2021)

Die **mutismusspezifische Behandlung** dient der Prävention von Folgeproblematiken. Je eher die Störung erkannt und eine Therapie begonnen wird, umso effizienter wirkt diese (Schwartz et al., 2006; Subellok & Katz-Bernstein, 2010 & 2012). Studien belegen, dass erhebliche Beeinträchtigungen besonders hinsichtlich der sozio-emotionalen Entwicklung sowie der psychischen Gesundheit erwartbar sind, wenn der selektive Mutismus nicht behandelt wird und über das 10. Lebensjahr hinaus bestehen bleibt.

(Kolvin & Fundudis, 1981; Remschmidt et al., 2001; Steinhausen et al., 2006; Chavira & Shipon-Blum, 2007)

Medikamentöse Behandlung

Eine Behandlung mit Medikamenten sollte nur in schwerwiegenden Fällen erwogen werden, bei denen kausal oder komorbid eine Depression, generalisierte Angststörung oder Soziophobie vorliegt und andere Interventionen nicht ausreichend Wirkung zeigen. In diesen Fällen werden unterstützende Behandlungserfolge für eine medikamentöse Therapie mit selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern beschrieben.

(von Frankenberg & Schröter, 2021)

Prognose

ES GILT:

Ein frühzeitiger Therapiebeginn begünstigt die Prognose erheblich. Selbstwert, Partizipation, emotional-soziale Entwicklung, Bindungsverhalten, Stressmanagement und Resilienz können positiv beeinflusst werden. Zudem ist das Einbeziehen des Umfeldes und das Stabilisieren der Bezugspersonen Aufgabe der Therapie, sodass das Kind die unbewusst eingenommene Funktion als Symptomträger abbauen kann. Die Behandlung kann begonnen werden, sobald die Diagnosekriterien erfüllt sind. Selektiver Mutismus tritt häufig schon im Alter von 2 bis 5 Jahren auf.

(von Frankenberg & Schröter, 2021)

*„Neuere Studien weisen auf die **Therapierbarkeit des selektiven Mutismus [...]. In einer Metaanalyse von Studien zum Langzeitverlauf [...]** zeigen **74 % der Behandelten eine komplette Remission oder aber massive Verbesserung der Symptomatik.**“*

Die Dauer der Störung und das Alter der Betroffenen beeinflussen den Therapieerfolg.

(Melfsen & Walitza, 2017)



Ein schweigendes Kind kommt in die Praxis

STEP 1

BEOBACHTUNG

- Erstarrung/gesteigerter Körpertonus
- Kaum Blickkontakt
- Konsequentes Schweigen
- Kind wirkt abwesend, wie im Nebel, reagiert nicht/kaum

STEP 2

ANAMNESE

- Kriterien laut DSM-5 erfüllt?
- Laut Bezugsperson: Spricht das Kind zu Hause? +
- Spricht es in der Kita / Schule oder mit Fremden? -

STEP 3

KIND EINBEZIEHEN

- Antworten mit Skala (siehe Kapitel „Hilfsmittel“, S. 26, und „Umgang in der Arztpraxis“, S. 22)

STEP 5

DIAGNOSE- STELLUNG

- Selektiver oder elektiver Mutismus (Begriffe sind synonym)

STEP 4

VERDACHT

- Screeningbögen nutzen, z. B.:
 - DortMuS-Eltern oder
 - E-S-K-M

STEP 7

ALTERNATIVE UNTERSUCHUNGS- METHODEN

- Videoaufnahmen zur Sprachstandserhebung

STEP 6

ELTERN

- Anlaufstellen (siehe Kapitel „Informationen und Links“, S. 32)
- Aussicht: Prognose ist günstig.
- Auftrag: Suche einer Therapeutin bzw. eines Therapeuten mit Spezialisierung auf Mutismus

STEP 9

FACHLICHER AUSTAUSCH

- Mit Therapeut*in, ggf. mit Bitte um ausführlichen Bericht
- Sind weitere Maßnahmen indiziert? Zum Beispiel Kur oder Familienhilfe
- Medizinisch: begleitend z. B. bei Enkopresis, Obstipationen, Angst-, Zwangs-, Schlaf- oder Essstörungen

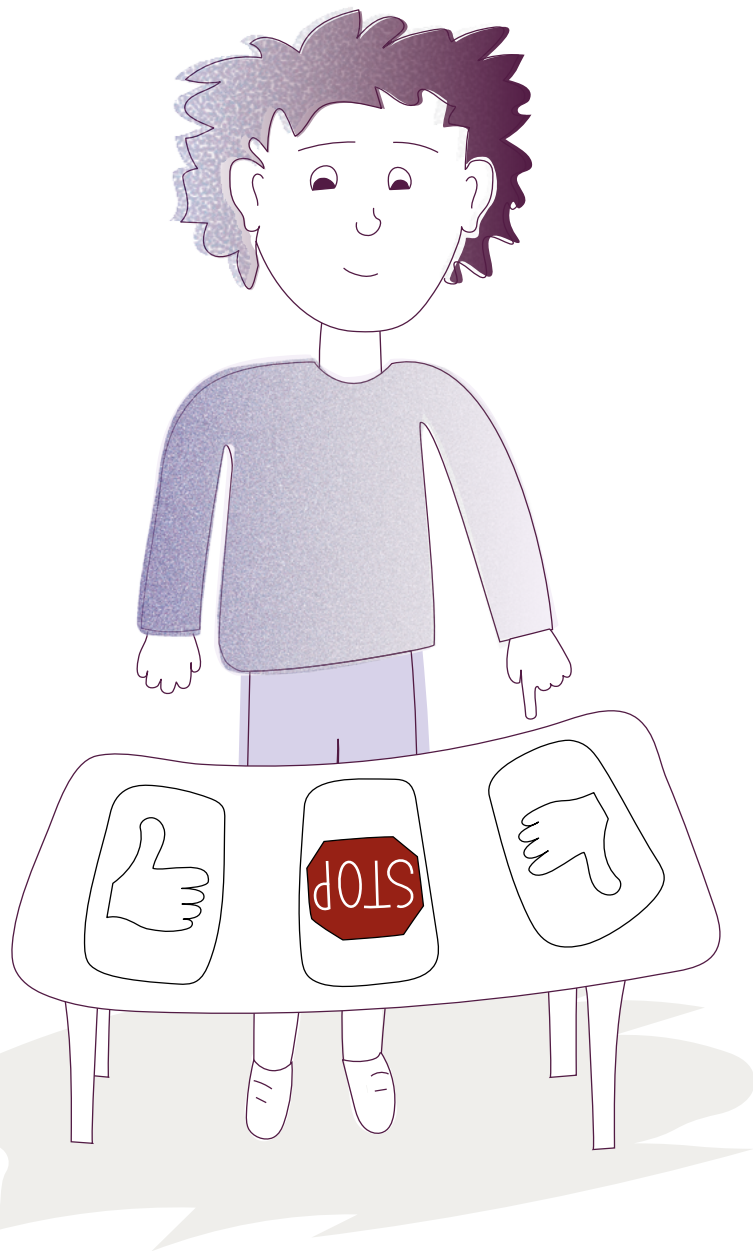
STEP 8

VERORDNUNG

- Ausstellen, wenn Termin mit Expert*in vereinbart wurde
- Diagnoseschlüssel: siehe S. 5 & 16
- für: Logopädie/Sprachtherapie, Heilpädagogik, Psychotherapie o. Ä. (auf Spezialisierung „Mutismus“ achten)



Flussdiagramm



Praktische Tipps für den Umgang in der Arztpraxis

Positive Haltung

Nehmen Sie das Schweigen nicht persönlich. Das Kind möchte kooperieren, es KANN nur nicht. Zeigen Sie Zuversicht: Die Prognose ist günstig, dass das Schweigen überwunden wird. Sie können die Haltung annehmen, dass das Sprechen NOCH nicht geht. Das positive Unterstellen einer günstigen Entwicklung ist das, was die Kinder schwere Zeiten überstehen lässt. Eine Patientin formulierte es einmal so: „Mir hat am meisten geholfen, dass Sie an mich geglaubt haben in einer Zeit, als ich es selbst nicht konnte“.

Druck rausnehmen

Sie können den Patient*innen/Angehörigen sagen, dass es nicht notwendig ist zu sprechen und dass sie auch die nonverbale Kommunikation schätzen: „Es ist in Ordnung, dass das Sprechen noch nicht geht. Irgendwann wird es leichter, bis dahin probieren wir es übers Zeigen.“

Sicherheit schaffen

Die Betroffenen erschrecken durch die überaktive Amygdala besonders leicht, daher empfiehlt sich ein ruhiges, Sicherheit vermittelndes Auftreten und das Ankündigen dessen, was geschehen wird. Das Kind wird sich an Ihnen orientieren.

Zeit nehmen

Legen Sie die Termine für Patient*innen mit Ängsten bei sozialen Situationen möglichst in Praxiszeiten, in denen weniger Betrieb ist. Wenn möglich, können die Arzthelfer*innen in der Zeit vor der Behandlung schon ein vertrauensvolles Klima schaffen und erklären, was während des Termins geschehen wird.

Einverständnis einholen

Formulieren Sie zu Beginn des Termins, was geschehen wird und fragen Sie das Kind, ob sie beginnen können. Wenn das Kind verneint, erklären Sie ihm in knappen Worten den Sinn hinter ihrem Tun: „Ich helfe dir, dass du gesund bleibst/wirst und passe gut auf dich auf. Komm, wir schaffen das zusammen.“ Vereinbaren Sie ein nonverbales Grenzzeichen für „Stopp!“ (siehe „Hilfsmittel“, S. 26).

Orientierung geben

Versuchen Sie, möglichst viele Rituale einzuhalten, sodass die Patient*innen wissen, was geschieht. Das gibt Sicherheit und wirkt der Angst entgegen. Beispielsweise helfen Sätze wie: „Schön, dass du da bist. Schauen wir mal auf der Skala, wie es dir heute geht.“, die bei jedem Arztbesuch gleich sind. Auch können Sie sich zunächst einen Moment Zeit nehmen und sich die Hände desinfizieren, sodass das Kind in Ruhe ankommen kann. Wenn der Anfangsverdacht auf Mutismus besteht und das Kind sich beim ersten Termin nicht untersuchen lässt, vereinbaren Sie wenn möglich einen Folgetermin und klären Sie das Kind genau darüber auf, was dann geschehen wird. So hat es zwischen Termin 1 und 2 Zeit, sich darauf einzustellen. Durch das Wahren der Grenzen des Kindes haben Sie dadurch zusätzlich einen Vertrauensbonus erlangt.

Berührungen ankündigen

Patient*innen mit mutistischem Schweigen haben sehr unterschiedliche Grenzen in Bezug auf körperliche Berührung. Seien Sie daher besonders sorgsam und kündigen Sie an, was Sie tun wollen. Erklären Sie, dass die Untersuchung der Gesundheit dient und Sie besonders gut auf sie/ihn achten werden.

Bezugspersonen als Sprachrohr zulassen

Drängen Sie die Kinder während einer Untersuchung nicht zum Sprechen und schicken Sie auch die Eltern nicht aus dem Behandlungsraum. Die Kinder würden sprechen, wenn sie es könnten. Es handelt sich um eine starke physische Reaktion auf subjektiv erlebten Stress, der eine Körperblockade erzeugt und so das Sprechen verhindert. Geben Sie so viel Sicherheit wie möglich und beziehen Sie dabei sowohl das Kind als auch die Bezugsperson mit ein: „Ich merke, dass das Sprechen für dich gerade schwer ist. Ist es in Ordnung, dass ich dazu deine Mama befrage?“ Durch dieses Affect Labeling (Purps-Pardigol, 2021), eine implizite und hochwirksame Emotionsregulationsstrategie und die wohlwollende Unterstützung Ihrerseits, kann sich das Kind entspannen und besser auf Sie reagieren.

Blickkontakt dosieren

Der Blickkontakt sollte dosiert werden, da er von Menschen mit selektivem Mutismus häufig als anstrengend und zu konfrontativ erlebt wird. Ratsam ist die Fokussierung auf ein Übergangsobjekt (vgl. S. 26) oder ein Buch.

Antwortlatenz beachten

Unter Stress und dem Druck, antworten oder reagieren zu müssen (und auch zu wollen), kann sich der Erstarrungsmechanismus verstärken und selbst nonverbale Reaktionen stark verzögern. Bleiben Sie gelassen und geben Sie etwa 30 bis 60 Sekunden Zeit. Wichtig: Es steckt keine Absicht dahinter, es handelt sich um eine Blockade. Falls nicht reagiert werden kann, reagieren Sie darauf mit: „Ich merke, dass das gerade zu schwer war. Wollen wir stattdessen XY probieren?“

Cave:

Nicht nur über, sondern mit dem Kind sprechen.

Sinne ansprechen

Eine vertiefte, ruhige Atmung trägt zur vegetativen Regulation bei. Wenn Sie hochgradige Spannung bemerken, regen Sie zum Durchatmen an. Dazu können Sie beispielsweise Duftbücher nutzen, die einen spielerischen Charakter haben und den Fokus zunächst auf das Buch lenken, wie unter „Blickkontakt dosieren“ beschrieben ist. Der Klang Ihrer Stimme kann ebenfalls beruhigend wirken.

Verbindung herstellen

Verbundenheit gibt Sicherheit und reguliert dadurch Stressreaktionen.

„Zu mir kommen viele Kinder, die erst einmal ängstlich sind, das ist ganz normal. Ich bin selbst manchmal aufgeregt vor Arztbesuchen, aber ich atme dann ein paar Mal tief durch und weiß, dass mir die Ärzte helfen wollen und ich dort gut aufgehoben bin.“

(Pia Zucht)

Cave:

Nutzen Sie keine Formulierungen wie „Hab keine Angst, das tut nicht weh.“, denn Negationen können vom Gehirn nicht gut verarbeitet werden und am Ende bleibt die Botschaft von „Angst“ und „da tut etwas weh“ hängen. Dies ist vergleichbar mit dem rosafarbenen Elefanten, an den man NICHT denken soll.

Sprachstand erheben – Alternative Lösung für die Untersuchung

Sie können die Eltern bitten, mittels eines zuvor ausgehändigten Bildmaterials zu Hause die Situation nachzustellen und zu filmen. Dies kann dann separat oder mit dem Kind angeschaut und ausgewertet werden. Lob ist hierbei hilfreich, Kommentare wie: „Na siehst du, es geht doch!“ sind es nicht. Der Leidensdruck der Betroffenen ist hoch, daher würdigen Sie das, was das Kind von sich zeigen kann, auch wenn es nur wenig ist. Sie können gegebenenfalls Absprache mit der/dem Therapeut*in halten.



Hilfsmittel

Nutzen Sie folgende Hilfsmittel für den Austausch / die Kommunikation:

Zeichen-Karten verwenden

Ja, nein, gleich, stopp! – beispielsweise über Nicken/Kopfschütteln oder Handzeichen



Ankreuzmöglichkeiten oder Antwortkarten im Ampelsystem

Grün = ja, Gelb = bitte kurz warten / ich bin nicht sicher, Rot = nein (siehe QR-Codes S. 27)

Anti-Stress-Spielzeug bereithalten

Halten Sie eine Auswahl an Anti-Stress-Spielzeug bereit, z. B. Knetbälle und Ähnliches. Durch das Aktivieren des motorischen Kortex wird die Aktivität der Amygdala reduziert. Solches Spielzeug bewährt sich auch bei Jugendlichen oder Erwachsenen.

(Croos-Müller, 2012)

Übergangsobjekte

Für mutistische und sozial ängstliche Kinder ist es leichter, mit Übergangsobjekten in Kontakt zu treten als mit einem Erwachsenen. Ein solches Übergangsobjekt kann ein Stofftier oder eine Puppe sein. Sie können diese nutzen, um das Prozedere der Untersuchung zu erklären. Fragen Sie, ob Sie das Vorgehen daran zeigen sollen.

Infomaterial für Eltern

Informieren Sie die Eltern, dass es auf Mutismus spezialisierte Therapeut*innen und Vereine gibt, bei denen sie Hilfe erhalten (siehe „Informationen und Links“, S. 32).

Skala mit Ampelsystem verwenden

Mit Hilfe einer Skala kann das Befinden des Kindes differenziert erfragt werden. Sie finden dazu rechts eine Illustration und können sich die Skala sowie die Zeichen-Karten via QR-Code ausdrucken. Zeigen ist für die Betroffenen eher umzusetzen als zu sprechen.

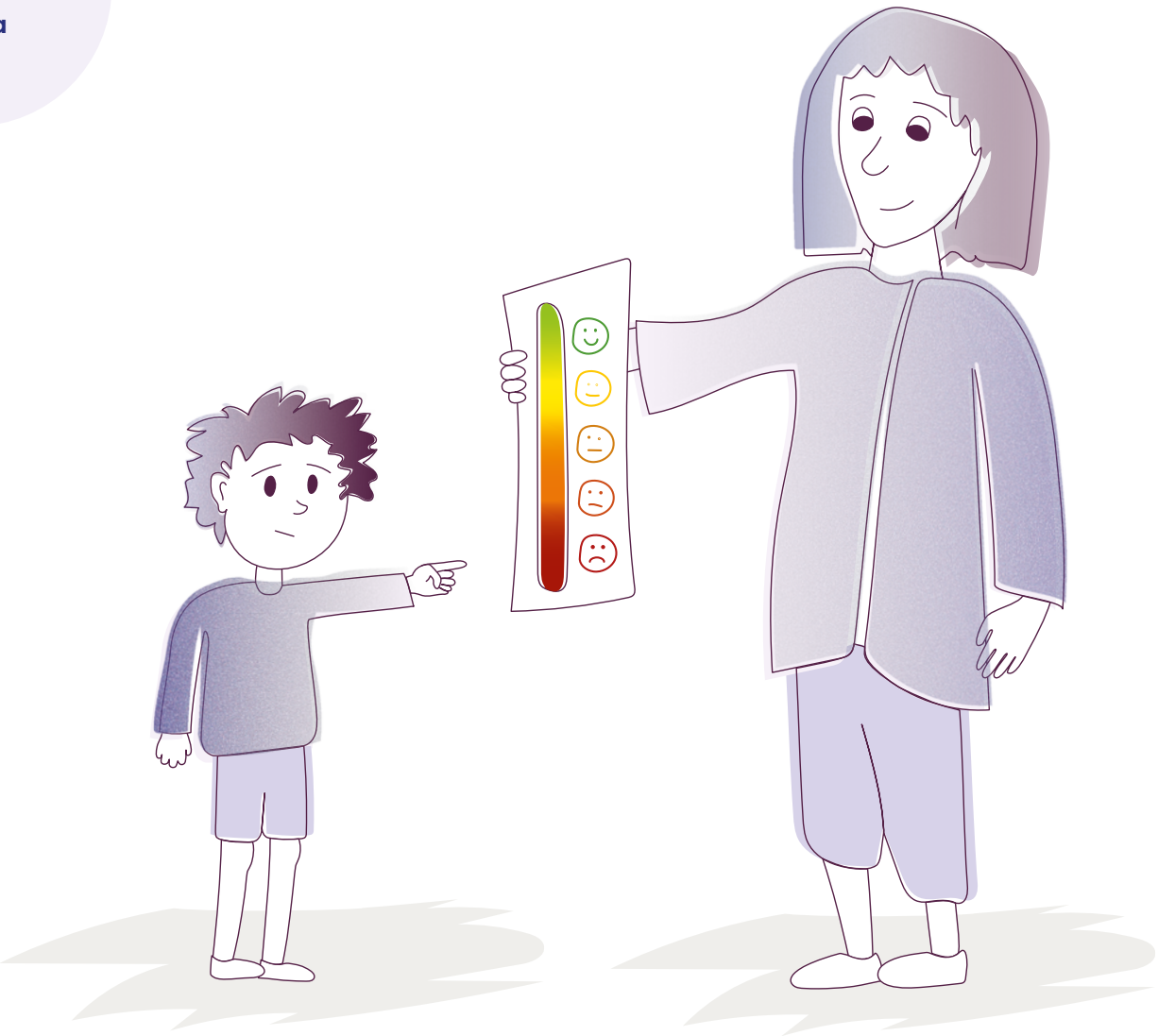
Die Smileys und die Ampelfarben der Skala helfen ebenfalls dabei auszudrücken, wie ein Kind beispielsweise das Sprechen in der Kita oder mit den Großeltern erlebt. Im grünen Bereich gibt es keine Einschränkungen, im orange-rot ist das Sprechen kaum bis gar nicht möglich.



Ampelsystem-Skala



Zeichen-Karten





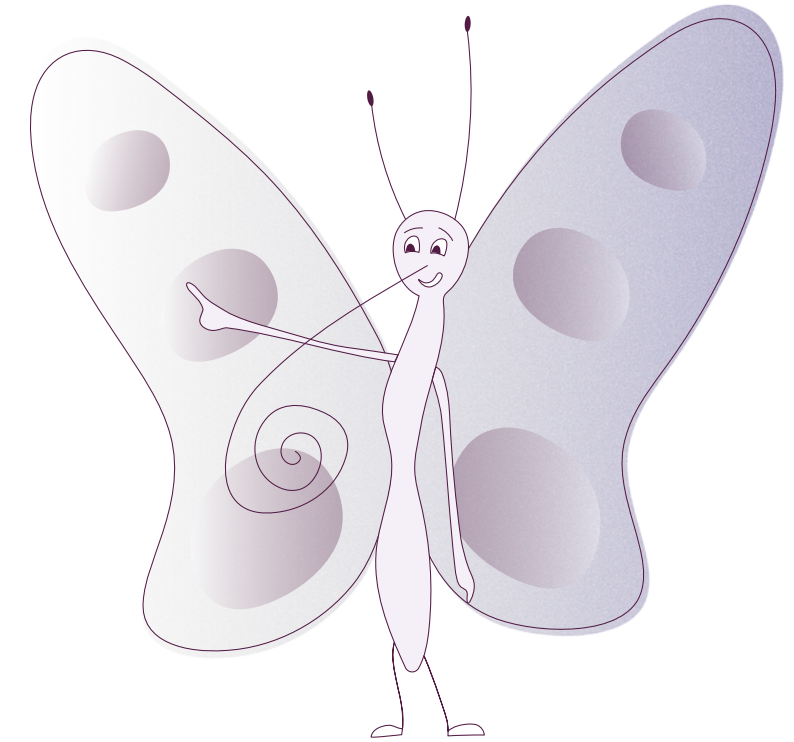
Umgang mit Jugendlichen und Erwachsenen

Nutzen Sie auch für Jugendliche und Erwachsene Skalen, um Fragen zu beantworten. Bieten Sie Stift und Papier an, um schriftlich zu reagieren. Falls die Blockade zu stark ist, können die Fragen anschließend via Mail beantwortet werden. Häufig haben die Patient*innen schon Wochen vor dem Arzttermin Angst davor. Hier kann das Affect Labeling helfen: Bitten Sie die Personen, die Bedenken und Fragen schon vorab zu formulieren und mitzubringen oder per Mail zu senden, sodass Sie darauf eingehen können.

Betroffene auf den Arztbesuch vorbereiten

Die Bezugspersonen sind häufig ebenfalls angespannt. Regen Sie deshalb gern dazu an, dass sich die Familie zuvor reguliert. Eine leicht umsetzbare Möglichkeit bietet z. B. ein Mitmachvideo auf YouTube: **Die Reise des Schmetterlings**. Das Video beinhaltet aufeinander abgestimmte Übungen zur Stressregulation nach der „Somatic Experiencing®“-Methode von Peter Levine. Die Bezugspersonen können die Übungen gemeinsam mit dem Kind durchführen und somit beruhigter zum Arzt gehen.

Empfehlen Sie den „Wegweiser für den Arztbesuch“ auf der Website mutismus.de (siehe QR-Code unten), um das innerfamiliäre Einstimmen auf den Termin und die Kommunikation mit dem Kind zu begünstigen oder laden Sie ihn sich gern selbst für die Praxis herunter.



Wegweiser für den Arztbesuch

Die Geschichte von Alwa, die das Hüpfen lernte

(gekürzt)

Alwa war fünf Jahre alt, ein zierliches Mädchen mit blonden Haaren und wachen grünen Augen. Sie hatte viele kreative Ideen und ein starkes Gespür für Menschen und die Welt um sie herum. Doch Alwa fühlte sich anders als die anderen Kinder, als würde ein unsichtbarer Graben sie von ihnen trennen. Während andere leicht miteinander redeten und spielten, blieb Alwa oft stumm und reglos. Besonders in der Kita war es schwierig für sie. Die vielen Kinder und Eindrücke machten ihr Angst – sie konnte nicht sprechen. Es fühlte sich an, als ob eine große Mauer sie umgab. Ihre Eltern waren liebevoll, doch sie verstanden nicht immer, was in Alwa vorging.

Zu Hause war Alwa anders. Mit ihrer Familie und ihren Tieren konnte sie spielen, lachen und Geschichten erfinden. Doch an manchen Tagen, wenn sie besonders verunsichert war, wurde sie wütend und laut. Eines Tages brachte ihre Mutter sie zu einer fremden Frau, sie hieß Frau Fuchs. Sie war in einer Praxis, die ganz anders war als die Arztpraxen, die Alwa kannte. Hier war es gemütlich, und es gab viele Spielsachen. Obwohl Alwa nervös war und die Worte in ihrer Brust feststeckten, schaffte es Frau Fuchs, sie zu beruhigen. Sie erklärte Alwa, dass viele Kinder Schwierigkeiten mit dem Sprechen haben und gab ihr Hoffnung, dass es leichter werden würde.



Alwa fühlte sich von Frau Fuchs verstanden und auch irgendwie größer, weil diese Frau fest an sie glaubte. Woche für Woche besuchte Alwa Frau Fuchs. Diese erzählte von einer Schnecke, die wie Alwa Probleme mit dem Sprechen gehabt habe, es aber irgendwie geschafft hat, das Schweigen zu überwinden. Das machte Alwa Mut. Eines Tages geschah es: Während eines Spiels sprach Alwa zum ersten Mal mit Frau Fuchs. Ganz leise sagte sie „acht“, als sie spielte. Frau Fuchs tat so, als wäre es das Normalste der Welt, und Alwa fühlte sich wohl.

Mit der Zeit wurde das Sprechen immer leichter, und Alwa konnte sogar darüber reden, wann und wo es noch schwer war. Frau Fuchs half ihr, sich ihren Gefühlen zu stellen. Sie spielten aufregende Spiele, bei denen Alwa sich stark und mächtig fühlte. An schlechten Tagen warfen sie gemeinsam Wutbälle gegen die Tür, was Alwa half, ihre Wut rauszulassen. Nach und nach begann Alwa, mit anderen Menschen zu sprechen – auch in der Kita. Das Leben wurde leichter und es gab weniger Streit zu Hause. Alwa fühlte sich nicht mehr so hilflos oder verwirrt. Frau Fuchs hatte ihr geholfen, ihre Gefühle zu ordnen und sich auszudrücken.

Als Alwa schließlich in die Schule kam, ließ sie das Schweigen hinter sich. Sie hatte gelernt, über den Graben zwischen ihr und den anderen Menschen zu hüpfen.

Pia Zucht

Informationen und Links

Auf den folgenden Seiten finden Sie viele hilfreiche Beiträge rund um das Thema Mutismus und Ansprechpartner*innen.

Stationäre Behandlung

- Rehaklinik Werscherberg
- Sprachheilzentrum Meisenheim
- AWO Sprachheilzentrum Werscherberg
- Reha-Fachklinik EUBIOS

Therapeutensuche nach Postleitzahl

Mutismus Selbsthilfe Deutschland e. V.

www.mutismus.de/unser-netzwerk#therapeutensuche

StillLeben e. V.

www.selektiver-mutismus.de/therapeutensuche

Dortmunder Mutismus Netzwerk

<https://spa.reha.tu-dortmund.de/mutismus/dortmun-dortmunder-mutismus-netzwerk/therapeutinnenverzeichnis>

YouTube-Videos zur Übersicht

- Mutismus – Wenn Kinder nicht mehr sprechen
(Interview mit Pia Zucht)
- Was ist Selektiver Mutismus?
- Selektiver Mutismus im Kindergarten
(Film von Agata Wehrli, Fachhochschule Nordwestschweiz)

Podcast

- Sprachbildung in Kitas: Folge 08 Mutismus.
(Interview mit Kerstin Bahrfeck)



Linkliste

Literaturempfehlungen

Für Fachpersonen

- **Selektiver Mutismus bei Kindern –**
Erscheinungsbilder, Diagnostik und Therapie
Nitza Katz-Bernstein, 2023
(Ernst Reinhardt Verlag)
- **Das stille Kind ist das vergessene Kind –**
Selektiven Mutismus interdisziplinär
überwinden
Franziska Florineth-Baatsch et al., 2024
(Hogrefe Verlag)

Für Betroffene/Angehörige

- **In Gedanken ein Fuchs –** Ein Buch für sozial
ängstliche Kinder, die selber kleine Füchse sind
Joan Schaaf et al., 2018 (Hogrefe Verlag)
- **Selina Stummfisch –** Wenn Kinder schweigen
Karen-Susan Fessel, 2019
(Balance Buch + Medien Verlag)
- **Mila spricht! –** Ein Bilderbuch zum selektiven
Mutismus
Babette Bürgi Wirth & Stefanie Kolb, 2023
(Ernst Reinhardt Verlag)

- **Der Junge in der Nusschale –** Eine
Geschichte, die schweigenden, stotternden und
schüchternen Kindern Mut macht
Anne Gauß, 2013 (iskopress)
- **Anna und Obur –** Eine Mutmach-Geschichte für
schweigende Kinder
Karin Birchler Hofbauer & Monika Birchler-Küchlin,
2023 (Schulz-Kirchner Verlag)
- **Es wird gut, kleine Maus –** Ein Bilderbuch
für Kinder, die nach einer Verlusterfahrung
verstummen
Gabriele Kloes, 2016
(Mabuse-Verlag)
- **Wenn fremde Anwesenheit verstummen lässt –**
Leben mit selektivem Mutismus
(aus Erwachsenenperspektive)
Sandra Melliger, 2013 (Books on Demand)

Literaturverzeichnis

- autismus deutsche Schweiz (Hrsg.). (2022). *Endlich klappt der Arztbesuch für Menschen im Autismus-Spektrum*. Careum Verlag.
- Bohnet, K. (o. J.). *Über uns (Unsere Vision)*. helpers circle. <https://helperscircle.de/team> (Abruf 23.08.2024).
- Chavira, D. A., Shipon-Blum, E., Hitchcock, C., Cohan, S. & Stein, M. B. (2007). Selective mutism and social anxiety disorder: all in the family? *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 46(11), S. 1464–1472. <https://doi.org/10.1097/chi.0b013e318149366a>
- Croos-Müller, C. (2012). *Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch: Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co*. München: Kösel-Verlag.
- Dilling, H. & Freyberger H. J. (Hrsg.) (2019). *ICD-10 Taschenführer zur ICD-10 Klassifikation psychischer Störungen*. Bern: Hogrefe Verlag
- Florineth-Baatsch, F., Katz-Bernstein, N. & Muchenberger-Gebauer, A. (2024). *Das stille Kind ist das vergessene Kind*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Hartmann, B. & Lange, M. (2024). *Mutismus im Kinder- und Jugendalter – Für Angehörige, Betroffene sowie therapeutische und pädagogische Berufe*. Schulz-Kirchner Verlag.
- Katz-Bernstein, N. (2019). *Selektiver Mutismus bei Kindern*. Ernst Reinhardt Verlag.
- Kolvin, I. & Fundudis, T. (1981). Elective mute children: psychological development and background factors. *Journal of Child and Psychiatry, and Allied Disciplines*, 22(3), S. 219–232. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1981.tb00548.x>
- Kramer, J. & Bahrfeck, K. (2024). *Selektiver Mutismus – ein interdisziplinäres Phänomen im Kindergarten. Überblick über therapeutische Ansätze und Organisationsstrukturen in Deutschland*. A.I.M.U.SE. <https://www.aimuse.it/wp20/wp-content/uploads/2024/06/2-KRAMER-BAHRFECK-Webinar-DE.pdf> (Abruf 18.07.2024)
- Meer-Walter, S. (2024). *Autistisch? Kann ich fließend!* Beltz Verlag.
- Melfsen, S., Romanos, M., Jans, T. & Walitza, S. (2021). Betrayed by the nervous system: a comparison group study to investigate the „unsafe world“ model of selective mutism. *Journal of Neurotransmission*, 128(9), S. 1433–1443. <https://doi.org/10.1007/s00702-021-02404-1>
- Melfsen, S. & Walitza, S. (2017). Behandlungsmethoden des selektiven Mutismus. *Sprache · Stimme · Gehör*, 41(02), S. 91–97. <https://doi.org/10.1055/s-0043-103489>

- Melfsen, S. & Walitza, S. (2021). Selektiver Mutismus. In T. Schnell & K. Schnell (Hrsg.) *Handbuch Klinische Psychologie* (S. 1–23). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45995-9_2-1.
- Purps-Pardigol, S. (2021). *Leben mit Hirn – Wie Sie Ihre Potenziale entfalten, egal was um Sie herum geschieht*. Campus Verlag.
- Remschmidt, H., Poller, M., Herpertz-Dahlmann, B., Hennighausen, K. & Gutenbrunner, C. (2001). A follow-up study of 45 patients with elective mutism. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 251(6), S. 284–296. <https://doi.org/10.1007/pl00007547>
- Rogoll, J. & Ströhle, A. (2021). Selektiver Mutismus versus Autismus-Spektrum-Störung: Diagnose und Differenzialdiagnose. *Mutismus.de – Fachzeitschrift für Mutismus-Therapie, Mutismus-Forschung und Selbsthilfe*, 13(24), S. 5–9.
- Schwartz, R. H., Freedy, A. S. & Sheridan, M. J. (2006). Selective mutism: are primary care physicians missing the silence?. *Clinical Pediatrics*, 45(1), S. 43–48. <https://doi.org/10.1177/000992280604500107>
- Stein, M. B., Yang, B. Z., Chavira, D. A., Hitchcock, C. A., Sung, S. C., Shipon-Blum, E. & Gelernter, J. (2011). A common genetic variant in the neurexin superfamily member CNTNAP2 is associated with increased risk for selective mutism and social anxiety-related traits. *Biological psychiatry*, 69(9), 825–831. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2010.11.008>
- Steinhausen, H.-C., Wachter, M., Laimboeck, K. & Winkler Metzke, C. (2006). A long-term outcome study of selective mutism in childhood. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines*, 47(7), S. 751–756. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01560.x>
- Subellok, K. & Katz-Bernstein, N. (2010). Einfach scheu oder selektiv mutistisch? Früherkennung von Risikofaktoren. In C. Leyendecker (Hrsg.), *Gefährdete Kindheit. Risiken früh erkennen, Ressourcen früh fördern* (S. 159–168). Kohlhammer.
- Subellok, K. & Starke, A. (2012). Selektiver Mutismus. In S. Niebuhr-Siebert & U. Wiecha (Hrsg.), *Kindliche Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen* (S. 219–237). Elsevier.
- von Frankenberg, J. & Schröter, C. (2021). Selektiver Mutismus in der sprachtherapeutischen Praxis. *Pädiatrische Praxis* 96, S. 258–264.
- Zucht, P. (im Druck, geplant 2024). Mut ist Muss! Mutismus-Therapie als ganzheitliches Konzept. *Forum Logopädie*, 38(5).

ÜBER DIE AUTORIN



Pia Zucht



www.mutwind.de



kontakt@mutwind.de

Pia Zucht ist Logopädin und Heilpraktikerin für Psychotherapie mit den Schwerpunkten auf körper- und bindungsorientierte Therapie sowie Hypnotherapie. Seit dem erfolgreichen Abschluss ihres Staatsexamens an der Berliner Charité 2015 arbeitet sie als Logopädin in Berlin. Sie ist zertifizierte Mutismus-Therapeutin nach DortMuT und hat sich auf die Behandlung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit selektivem Mutismus spezialisiert. Seit 2017 ist Pia Zucht in der logopädischen Praxis „Sprachbaum“ in Berlin tätig. Sie doziert an der Universität Erfurt sowie an Kitas, Schulen und auch an verschiedenen Seminar- und Fortbildungsinstituten wie beispielsweise Rheine, Loguan und der Heimerer Akademie.

Pia Zucht plant, 2025 nach Erfurt zu ziehen und dort ein Therapie-Institut zu gründen. Dieses wird sich vor allem auf die Behandlung von selektivem Mutismus, die Begleitung von herausfordernden Lebensthemen und körperorientierte Therapieansätze konzentrieren. Daneben soll dort ein breites Spektrum an logopädischen Leistungen und psychologischen Interventionen angeboten werden. Forschung, Beratung und Lehre finden im Rahmen des Instituts ebenfalls ihren Platz.

Impressum

Herausgeber

Mutismus Selbsthilfe Deutschland e. V.
Oberpleiser Straße 25
50939 Köln
Telefon: 015679 504175
E-Mail: info@mutismus.de

Redaktion

Text: Pia Zucht
Illustration: Sarah Nabjinsky
Layout: Miriam Frommer

Bildnachweise

Seventyfour – stock.adobe.com
ShotStudio – depositphotos.com
peopleimages.com – stock.adobe.com
Andrey Kiselev – stock.adobe.com
Valerii Honcharuk – stock.adobe.com
stock.film – stock.adobe.com
Sunny studio – stock.adobe.com

© Mutismus Selbsthilfe Deutschland e. V. 2024



www.mutismus.de



[facebook.com/
MutismusSelbsthilfeDeutschland](https://facebook.com/MutismusSelbsthilfeDeutschland)



instagram.com/mutismus.de

Dieser Flyer wurde im Rahmen der Selbsthilfe
durch die DAK-Gesundheit gefördert.



Hier klicken und
mit Spenden helfen!